EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 80958
SERVICIO : UTI HSC
FECHA : 2024-03-19 12:45:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: ISOLDA MARIBEL RAMIREZ PEREZ			RUN	: 10.397.614-6
F.Nac	: 17-09-1965	Edad	: 58 AÑOS, 6 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: SAN MIGUEL DE ABLEMO			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA C	Teléfono	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-03-16	Fecha Egreso	: 2024-03-19 12:45:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I64-ACCIDENTE VASCULAR ENCEFALICO AGUDO, NO ESP.COMO HEMORRAGICO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

- Deficit neurológico en estudio. ACV menor derecho vs aura migrañosa
- Antecedentes: Hipertensión arterial - Al menos 4 eventos cerebrovascualares, todos ellos consistentes en cefalea asociado a fenomenos positivos sensitivos y posterior hemiparesia izquierda - Dislipidemia

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I63.3-INFARTO CEREBRAL DEBIDO A TROMBOSIS DE ARTERIAS CEREBRALES (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Antecedentes mórbidos:
- Hipertensión arterial
- Al menos 4 eventos cerebrovascualares, todos ellos consistentes en cefalea asociado a fenomenos positivos sensitivos y posterior hemiparesia izquierda
- Dislipidemia

Alergias:
- Sin antecedentes de alergia a medicamentos

Medicamentos de uso actual:
- Aspirina 100 mg, 1 comp al día
- Enoxaparina 40 mg 1 jeringa al día SC
- Losartan 50 mg cada 12 horas
- Amlodipino 10 mg 1 comp al día

Habitos:
- OH: no
- Tabaco: no
- Drogas: no

Diestro mRS 1
Paciente con antecedentes de HTA, y al menos 4 eventos interpretados como causa cerebrovascular, consistentes en cefalea asociado a parestesias (fenómenos positivos sensitivos de marcha lenta) posterior hemiparesia BC izquierda. Con hipoestesia secuelar BC izquierda.
Consulta en SU de HSC el 15/03/24 por cuadro de inicio a las 17 horas consistente en sensación de mareos y posterior cefalea, progresa con párestesia de ESI y posterior debilidad de hemicuerpo izquierdo.
Al ingreso con FC 58 lpm RR, PA 220/110 mmHg, T° 36.9°C, Sat 97%. Al examen descrito por teleneurología NIHSS 4 puntos a expensas a hemihipoestesia izquierda y hemiparesia FBC izquierda. En estudio complementario sin alteraciones de relevancia. Se realiza TC de encéfalo que descarta componente hemorrágico y angioTC sin alteraciones vasculares de relevancia. Se indicó trombolisis con regresión de NIHSS a 1 punto (sensitivo) se hospitaliza en UTI. Control TC de encéfalo sin contraste de control sin complicaciones hemorrágicas, y no se hacen evidentes lesiones nuevas.

Durante estadía sin registro de arritmias, hemodinamia con necesidad de aumento de tratamiento antihipertensivo oral en forma progresiva. Sin otras molestias.
Se toma conocimiento del caso el 18/03/24 paciente en buenas condiciones generales, afebril, con mejor perfil de presiones arteriales, se revisa monitor sin registro de arritmias durante estadía en UTI.
En cuanto a lo neurológico, solo con hallazgos secuelares antiguos. No refiere otras molestias.
Logra alimentación con régimen liviano hiposódico, en cuanto a lo kinésico logra marcha estática con asistencia de 1 operador.
Cuadro se manejará operacionalmente como evento cerebrovascular para estudio, sin embargo historia y presentación clínica no claramente compatible considerando 4 eventos de presentación estereotipada y al examen elementos funcionales.
Considerando estos elementos, se acuerda en conjunto con la paciente hospitalización domiciliaria para estudio y seguimiento posterior ambulatorio.

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo asistido vgilado
2. Régimen liviano hiposódico
3. Aspirina 100 mg, 1 comp al día, vía oral.
4. Atorvastatina 40 mg, 2 comp por noche, vía oral.
5. Losartan 50 mg, 1 comp cada 12 horas, vía oral.
6. Amlodipino 10 mg, 1 comp por noche, vía oral.
7. Omeprazol 20 mg, 1 capsula al día, vía oral.
8. Hidroclorotiazida 50 mg, 1/2 comp al día, vía oral.
9. Kinesioterapia motora
10. Fonoaudiología
11. Ecocardiograma y Holter de ritmo en forma ambulatoria
12. RM de encéfalo con contraste
13. Control GES en CAE neurología HSC
14. Control en servicio de urgencias en caso de necesidad. Se explican situaciones de reconsulta.

EXÁMENES Y RESULTADOS

- 18/03/24 Creat 1.0, MDRD 56.9, Uremia 29, ELP 142/3.8/109, Hb 13.7, Hto 40.8, Leuco 8700, Plaq 225.000, VHS 13. PCR 6.5. INR 1.03. TTPa 32.
- 16/03/24 Hb 12.7, Hto 36.9, leuco 9900, Plaq 205.000, VHS 5. INR 1.1. TTPa 24. TSH 3.78. HbA1c 5.6, RPR no reactivo
- 15/03/24 Glic 100, Creat 0.9, Uremia 43, ELP 140/4.4/106, PCR 11.5. INR 0.94. TTPA 23. Tropo 2.4

OBSERVACIONES:

Al examen neurológico al momento del alta
SV FC 57 lpm RR, T° 36.3 °C, PA 138/83 mmHg, Sat 96% amb, HGT 93
- Vigil, OTE, atenta, sin alteración lenguaje, sin disartria.
- Pupilas isocoricas, RFM +/+, CV normal. OCM normal. Sensibilidad facial refiere hipoestesia izquerda, mueca simétrica. Protruye lengua en linea media
- PMP oscila y prona escasamente ESI. No se repite en otras pruebas de mínima paresia. ROT normales, plantar flexor bilateral.
- hipoestesia moderada BC izquierda
- Coordinacion normal.
- Signos meningeos negativos.

Christian Alejandro Norambuena Aguayo
MEDICO TRATANTE
16447719-3

JEFE SERVICIO